Клинические рекомендации

# Полипозный риносинусит

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **J33.0** — Полип полости носа<br>**J33.1** — Полипозная дегенерация синуса<br>**J33.8** — Другие полипы синуса<br>**J33.9** — Полип носа неуточненный |
| Пациенты | взрослые |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/890_1 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Основные положения** 3

**2. Клиническая картина и классификация** 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и патогенез 4

2.3 Классификация 4

2.4 Шкала Lund–Kennedy 4

2.5 Клиническая картина 5

2.6 Жалобы и анамнез 5

**3. Диагностика** 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Степень тяжести 6

3.3 Осмотр оториноларинголога 6

3.4 Передняя риноскопия 6

3.5 Эндоскопическая ревизия полости носа и носоглотки 6

3.6 Компьютерная томография околоносовых пазух 6

3.7 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 7

3.8 Патолого-анатомическое исследование 7

3.9 Цитологическое исследование 7

3.10 Консультации пульмонолога и аллерголога-иммунолога 7

3.11 Исследование скорости мукоцилиарного транспорта (сахариновый тест) 7

**4. Лечение** 7

4.1 Ограниченный полипоз (полипы в пределах среднего носового хода) 7

4.2 Системные кортикостероиды 8

4.3 Блокаторы лейкотриеновых рецепторов ..... 8
4.4 Системная антибактериальная терапия ..... 8
4.5 Тяжёлое течение, сочетание с бронхиальной астмой: генно-инженерная биологическая терапия ..... 8
4.6 Неэффективность медикаментозной терапии, распространённый полипоз: хирургическое лечение ..... 10
4.7 Послеоперационное ведение ..... 10
**5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации** ..... **10**
5.1 Показания к госпитализации ..... 11
**6. Источник и актуальность** ..... **11**
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации ..... 12

## 1. Основные положения

- Диагноз устанавливают на основании:
  1. жалоб и анамнеза;
  2. данных осмотра;
  3. передней риноскопии;
  4. эндоскопии полости носа и носоглотки;
  5. компьютерной томографии (КТ) околоносовых пазух.
- Препаратом выбора является мометазон в форме назального спрея по 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки, курс **3–6 месяцев**. Если симптомы не уменьшаются **в течение 5–6 недель**, рассматривают вопрос о хирургическом лечении.
- Системная антибактериальная терапия при полипозном риносинусите не рекомендуется.
- Генно-инженерная биологическая терапия (дупилумаб, омализумаб или меполизумаб) рекомендуется:
  1. при тяжёлом течении;
  2. при сочетании с бронхиальной астмой.
- Показания к хирургическому лечению:
  1. неэффективность медикаментозной терапии;
  2. распространённый полипоз.

  Оптимальным методом является функциональная эндоскопическая риносинусохирургия.
- В течение первого года после операции пациента осматривают **каждые 3 месяца**.

## 2. Клиническая картина и классификация

### 2.1 Определение

Полипозный риносинусит (ПРС): фенотип хронического риносинусита, гетерогенное по этиологии и патогенезу хроническое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух (ОНП) продолжительностью **более 12 недель**.

**Сопровождается**

1. ремоделированием слизистой оболочки;
2. образованием и рецидивирующим ростом полипов.

Полипы носа представляют собой доброкачественные новообразования слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.

Т2-эндотип ПРС характеризуется воспалением с эозинофилией крови или ткани либо с повышенным уровнем общего иммуноглобулина Е (IgE). К нему относятся эозинофильный хронический риносинусит, аллергический грибковый риносинусит и центральная компартментная атопическая болезнь (CCAD), то есть изолированные полипозные изменения слизистой оболочки верхней и средней носовых раковин и задневерхних отделов перегородки носа у пациентов с установленной аллергией к ингаляционным аллергенам.

### 2.2 Этиология и патогенез

**В развитии ПРС участвуют**

1. нарушения врождённого и адаптивного иммунитета;
2. аллергия;
3. генетически обусловленные заболевания: иммунодефициты, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия;
4. изменения внутриносовой анатомии;
5. бактериальная, грибковая и вирусная инфекция.

Вместе или по отдельности эти факторы поддерживают хроническое воспаление слизистой оболочки носа, которое приводит к образованию полипов и рецидивам.

Эозинофильный и неэозинофильный эндотипы ПРС различаются клиническими проявлениями, течением и ответом на лечение.

Из анатомических изменений у больных риносинуситом наиболее часто встречаются искривление перегородки носа (36%), concha bullosa (30%), клетки Оноди (12%) и клетки Галлера (6%), реже парадоксальный изгиб средней носовой раковины (3%) и пневматизация крючковидного отростка (2%).

### 2.3 Классификация

Единая классификация отсутствует. По клиническим и эндоскопическим данным выделяют три стадии:

1. полипы ограничены средним носовым ходом;
2. полипы выходят за пределы среднего носового хода;
3. полипы обтурируют соответствующую половину носа.

Для эндоскопической оценки применяется шкала Lund–Kennedy: полипы, отёк и отделяемое оцениваются отдельно справа и слева, каждый признак от 0 до 2 баллов.

### 2.4 Шкала Lund–Kennedy

| Признак | 0 баллов | 1 балл | 2 балла |
|---|---|---|---|
| **Полипы** | Полипы отсутствуют | Полипы в пределах среднего носового хода | Полипы распространяются за пределы среднего носового хода |
| **Отёк** | Отёк отсутствует | Умеренный отёк | Значительный отёк |
| **Отделяемое** | Отделяемое отсутствует | Прозрачное отделяемое | Густое гнойное отделяемое |

**Шкала Lund–Mackay по данным КТ, справа и слева отдельно**

1. каждая пазуха: 0 баллов без изменений, 1 балл при частичном затенении, 2 балла при тотальном затенении;
2. остиомеатальный комплекс: 0 баллов, если интактен, 2 балла при обтурации;
3. сумма для каждой стороны от 0 до 12 баллов, общая сумма от 0 до 24.

> Таблица шкалы Lund–Mackay в приложении Г3 не совпадает с текстом раздела 1.5. Верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости указаны в ней дважды, задние клетки решётчатой кости отсутствуют. Остиомеатальный комплекс в таблице оценивается в 0, 1 или 2 балла, в тексте только в 0 или 2 балла. В строке «Общее количество баллов» справа указаны 0, 7 и 14, слева 0, 1 и 2, хотя согласно ключу под таблицей сумма составляет от 0 до 12 на сторону. Расчёт следует проводить по тексту раздела 1.5.

По гистологическому строению различают отёчные полипы с преимущественно эозинофильной инфильтрацией (70–85% клеток), фиброзные полипы с преобладанием нейтрофилов, полипы с гиперплазией серозно-слизистых желёз и полипы с атипией стромы.

### 2.5 Клиническая картина

**Основные симптомы**

1. заложенность носа;
2. слизистые или слизисто-гнойные выделения, стекание отделяемого по задней стенке глотки;
3. ощущение тяжести и давления в области носа и в проекции околоносовых пазух;
4. диффузная головная боль;
5. снижение или отсутствие обоняния.

**В ряде случаев**

1. жжение и раздражение в горле, кашель, охриплость;
2. недомогание, снижение работоспособности, сонливость.

Необходимо оценить выраженность и продолжительность симптомов. При обострении симптомы усиливаются.

### 2.6 Жалобы и анамнез

**Группы жалоб**

1. назальные: затруднённое носовое дыхание, выделения из носа, снижение или отсутствие обоняния;
2. болевые: лицевая боль, ощущение распирания и давления в области лица, головная и зубная боль;
3. оро- и назофарингеальные: неприятный запах изо рта, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель, заложенность или боль в ушах;
4. системные: недомогание, утомляемость, снижение работоспособности.

Такое разделение позволяет подтвердить диагноз, оценить степень тяжести и выявить факторы, влияющие на выбор тактики лечения.

При сборе анамнеза уточняют время и причины появления симптомов, последовательность их развития, выраженность и динамику, влияющие на них факторы, ранее проведённые обследования и лечение.

**Отдельно выясняют**

1. связь симптомов с сезонными или круглогодичными аллергенами;
2. непереносимость ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);
3. симптомы бронхиальной астмы;
4. ПРС у близких родственников;
5. одно- или двусторонний характер симптомов;
6. рецидивирующие носовые кровотечения.

---

## 3. Диагностика

### 3.1 Критерии диагноза

**Обязательные критерии**

1. **две жалобы и более**, одна из которых: заложенность носа или выделения из носа.

**Возможные симптомы**

1. боль и давление в проекции околоносовых пазух;
2. снижение или отсутствие обоняния.

**Подтверждение**

1. передняя риноскопия;
2. эндоскопическая ревизия полости носа и носоглотки;
3. КТ околоносовых пазух.

Диагностическая специфичность повышается при сочетании двух или более субъективных симптомов с объективными признаками заболевания (данными эндоскопии носа и лучевых методов исследования).

### 3.2 Степень тяжести

Степень тяжести у всех пациентов оценивают по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Пациент оценивает выраженность симптома от 0 (симптом отсутствует) до 10 баллов (максимальная выраженность).

1. лёгкое течение: **0–3 балла**;
2. умеренное: **3–7 баллов**;
3. тяжёлое: **7–10 баллов**.

Значимое влияние на качество жизни оказывают симптомы выраженностью **5 баллов и более**.

### 3.3 Осмотр оториноларинголога

**Показания**

1. все пациенты с подозрением на ПРС или с установленным диагнозом.

**Диагностические признаки**

1. болезненность при пальпации и перкуссии в проекции околоносовых пазух;
2. признаки назальной обструкции: затруднённое носовое дыхание, гнусавость;
3. вязкое слизистое или слизисто-гнойное отделяемое;
4. полипы, при длительном течении и распространённом процессе видимые уже в преддверии носа;
5. в ряде случаев расширение спинки наружного носа.

### 3.4 Передняя риноскопия

**Показания**

1. все пациенты: оценка распространённости процесса и сопутствующей внутриносовой патологии.

### 3.5 Эндоскопическая ревизия полости носа и носоглотки

**Показания**

1. все пациенты: определение локализации и распространённости изменений слизистой оболочки.

Эндоскопия позволяет дифференцировать ПРС от заболеваний со сходной симптоматикой (новообразований, гипертрофии глоточной миндалины и задних концов нижних носовых раковин) и в сочетании с жалобами и анамнезом значительно повышает точность диагностики: специфичность 84%, чувствительность 66%.

### 3.6 Компьютерная томография околоносовых пазух

**Показания**

1. каждый пациент: оценка распространённости полипоза, состояния внутриносовых структур и костных стенок пазух.

Для повторных исследований в динамике вместо мультиспиральной КТ может применяться конусно-лучевая томография носа и околоносовых пазух, поскольку она сопровождается меньшей лучевой нагрузкой и не приводит к превышению годовой дозы на одну анатомическую зону.

### 3.7 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух

**Показания**

1. подозрение на новообразование полости носа и околоносовых пазух (дополнительно к КТ).

Рентгенография околоносовых пазух дешевле и доступнее, однако при ПРС она малоинформативна по сравнению с КТ.

### 3.8 Патолого-анатомическое исследование

**Показания**

1. все пациенты: операционный материал для дифференциации субтипов полипозного риносинусита.

### 3.9 Цитологическое исследование

**Показания**

1. все пациенты: выявление аллергического воспаления и выбор тактики лечения.

**Диагностические признаки**

1. содержание эозинофилов **более 10%** в поле зрения свидетельствует о выраженном аллергическом компоненте.

### 3.10 Консультации пульмонолога и аллерголога-иммунолога

**Показания**

1. подозрение на бронхиальную астму или атопию: консультация пульмонолога и (или) аллерголога-иммунолога.

### 3.11 Исследование скорости мукоцилиарного транспорта (сахариновый тест)

**Показания**

1. подозрение на первичную цилиарную дискинезию: исследование скорости мукоцилиарного транспорта сахариновым тестом.

---

## 4. Лечение

Медикаментозное и хирургическое лечение значительно и практически в одинаковой степени улучшают качество жизни при ПРС, что подтверждает приоритетное значение адекватной медикаментозной терапии.

### 4.1 Ограниченный полипоз (полипы в пределах среднего носового хода)

Кортикостероиды в форме назальных спреев применяют в качестве стартовой терапии при ограниченном полипозе, когда полипы не выходят за пределы среднего носового хода, а также в пред- и послеоперационном периоде.

**Мометазон, назальный спрей**

1. стартовая доза: по 100 мкг в каждую половину носа 2 раза в сутки, курс **3–6 месяцев**;
2. после достижения эффекта: по 2 впрыскивания в каждую половину носа 1 раз в сутки (200 мкг в сутки).

Предпочтение отдаётся препаратам с высокой топической активностью и низкой биодоступностью, поскольку они безопаснее при длительном применении. Назальные кортикостероиды уменьшают размеры полипов и заложенность носа, улучшают обоняние, предупреждают рецидивы и повышают качество жизни.

Если симптомы не уменьшаются **в течение 5–6 недель** применения мометазона, рассматривают вопрос о хирургическом лечении.

### 4.2 Системные кортикостероиды

Показания к системным кортикостероидам:

1. гиперреактивность бронхов, бронхиальная астма;
2. непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов;
3. рефрактерное течение ПРС;
4. выраженная атопия;
5. уменьшение воспаления в пред- и послеоперационном периоде.

**Преднизолон внутрь, в таблетках**

1. недостаточный контроль симптомов назальными кортикостероидами: коротким курсом 30–60 мг в сутки, **14 дней**.

Длительный или частый приём системных кортикостероидов может повышать риск нежелательных явлений и осложнений.

### 4.3 Блокаторы лейкотриеновых рецепторов

Блокаторы лейкотриеновых рецепторов применяют дополнительно к системным кортикостероидам или вместо них при их непереносимости, а также при рефрактерном к кортикостероидам течении ПРС.

### 4.4 Системная антибактериальная терапия

Системная антибактериальная терапия при ПРС не рекомендуется, поскольку доказательств её эффективности недостаточно, тогда как риски (развитие резистентности микрофлоры, анафилаксия, осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта) реальны.

Применение макролидов обсуждается в связи с их иммуномодулирующим и противовоспалительным действием, однако оптимальный препарат, доза и длительность терапии не определены, поэтому сделать однозначный вывод об их эффективности при ПРС не представляется возможным.

### 4.5 Тяжёлое течение, сочетание с бронхиальной астмой: генно-инженерная биологическая терапия

При тяжёлом течении ПРС, а также при сочетании ПРС с бронхиальной астмой для повышения эффективности лечения и снижения риска рецидивов рекомендуется генно-инженерная биологическая терапия (ГИБТ): дупилумаб, омализумаб или меполизумаб.

Препараты ГИБТ представляют собой рекомбинантные человеческие или гуманизированные моноклональные антитела класса IgG, избирательно связывающие IgE, интерлейкины или субъединицы их рецепторов (ИЛ-5, ИЛ-4/13).

Биологическую терапию назначают при двустороннем полипозе и хирургических вмешательствах в анамнезе, если выполнены **три критерия** из пяти:

1. признаки T2-воспаления: эозинофилы в ткани не менее 10 в поле зрения, или в крови не менее 150 клеток/мкл, или общий IgE не менее 100 МЕ/мл;
2. потребность в системных кортикостероидах (2 курса и более за год или приём **более 3 месяцев**) либо противопоказания к ним;
3. значимое снижение качества жизни: SNOT-22 не менее 40;
4. аносмия по результатам исследования обоняния;
5. бронхиальная астма, требующая регулярного применения ингаляционных кортикостероидов.

Ответ на терапию оценивают по пяти критериям:

1. уменьшение размеров полипов;
2. снижение потребности в системных кортикостероидах;
3. улучшение качества жизни;
4. улучшение обоняния;
5. уменьшение влияния сопутствующих заболеваний.

**Оценка ответа на генно-инженерную биологическую терапию**

1. 4–5 критериев: хороший ответ;
2. 2–3 критерия: умеренный ответ;
3. 0–1 критерий: слабый ответ или его отсутствие.

Эффективность оценивают **через 6 месяцев** и **через год**. При отсутствии ответа диагноз пересматривают, лечение прекращают и при необходимости переходят на другой препарат.

Лечение длительное, при его прерывании возможен рецидив.

**Беременность и лактация**

1. беременность: только если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода;
2. грудное вскармливание: решение о прекращении кормления или отмене препарата принимают с учётом пользы того и другого.

Решение о продолжении терапии принимается врачом с учётом тяжести заболевания и степени контроля обострений.

**Режимы дозирования генно-инженерных биологических препаратов**

| Препарат | Доза |
|---|---|
| **Дупилумаб** | Подкожно 300 мг (2 мл раствора 150 мг/мл) 1 раз в 2 недели, с 18 лет. При пропуске введения лечение возобновляется как можно скорее; у пациентов пожилого возраста коррекция дозы не требуется. |
| **Омализумаб** | Подкожно 75–600 мг 1 раз в 2 или 4 недели; доза и кратность введения определяются исходным уровнем IgE и массой тела и корректируются при значительном изменении массы тела. |
| **Меполизумаб** | Взрослым с плохо контролируемым тяжёлым ПРС — подкожно 100 мг 1 раз в 4 недели, длительно. |

### 4.6 Неэффективность медикаментозной терапии, распространённый полипоз: хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению для восстановления носового дыхания:

1. неэффективность медикаментозной терапии;
2. распространённый полипоз полости носа и околоносовых пазух.

Оптимальным методом является функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРСХ) под видеоэндоскопическим контролем.

**Включает**

1. удаление полипозно изменённой слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух;
2. восстановление проходимости естественных соустий;
3. коррекцию анатомических нарушений: как правило, септопластику и (или) резекцию носовых раковин, а также резекцию решётчатой буллы.

В зависимости от выраженности изменений объём вмешательства может быть ограничен минимально инвазивными методиками, обеспечивающими дренирование и аэрацию околоносовых пазух.

Всем пациентам перед операцией рекомендованы кортикостероиды в форме назальных спреев, что позволяет уменьшить кровопотерю, улучшить обзор операционного поля и сократить продолжительность вмешательства.

Результат хирургического лечения во многом определяется предоперационной медикаментозной подготовкой.

### 4.7 Послеоперационное ведение

После любого хирургического вмешательства необходима комплексная реабилитация, направленная на восстановление носового дыхания и функции слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.

**Реабилитация включает**

1. охранительный режим **10–14 дней и более**;
2. санацию полости носа и околоносовых пазух под эндоскопическим контролем в режиме «ирригация–аспирация» в раннем послеоперационном периоде;
3. бережное удаление плотных продуктов воспаления и фибрина для профилактики синехий;
4. при избытке вязкого отделяемого или корках орошение полости носа 0,9% раствором натрия хлорида.

---

## 5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациенты с ПРС подлежат диспансерному наблюдению у оториноларинголога для своевременного выявления ухудшения на фоне лечения или рецидива после операции и коррекции терапии.

Специфическая профилактика ПРС отсутствует.

Назальные кортикостероиды **в течение 6–12 месяцев** в пред- и послеоперационном периоде у большинства пациентов:

1. уменьшают выраженность воспаления;
2. улучшают качество жизни;
3. снижают частоту рецидивов;
4. увеличивают продолжительность ремиссии.

Кратность осмотров определяют индивидуально; в течение первого года после операции осматривают **каждые 3 месяца**. При рецидиве, требующем повторного хирургического вмешательства, и при подозрении на осложнённое течение выполняют КТ околоносовых пазух.

Пациентам с ПРС необходимо ежедневное применение назальных кортикостероидов, нередко в течение всей жизни с небольшими перерывами.

> Длительность применения назальных кортикостероидов в рекомендации указана по-разному: курс мометазона 3–6 месяцев (раздел 3.1), в пред- и послеоперационном периоде 6–12 месяцев (раздел 5), в разделе 7 ежедневно, нередко в течение всей жизни.

Наблюдение оториноларинголога должно быть систематическим, не реже одного раза в 3 месяца. Результат лечения зависит не только от операции и опыта хирурга, но и от приверженности пациента лечению и выполнения им рекомендаций.

> В разделе 5 указано, что кратность обследований определяется индивидуально, а осмотры каждые 3 месяца необходимы в течение первого года после операции. В разделе 7 и в информации для пациента указано постоянное наблюдение не реже одного раза в 3 месяца.

Основной задачей является комплексное лечение, обеспечивающее контроль симптомов и улучшение качества жизни. В ряде случаев необходимы повторные щадящие эндоскопические вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах.

При сопутствующей бронхиальной астме показано также наблюдение аллерголога-иммунолога.

### 5.1 Показания к госпитализации

Обследование и лечение пациентов могут проводиться как амбулаторно, так и в условиях стационара.

Показания к плановой госпитализации:

1. функциональная эндоскопическая риносинусохирургия (ФЭРСХ) с одномоментной коррекцией внутриносовых структур или без неё при отсутствии противопоказаний к хирургическому лечению;
2. подбор и коррекция терапии (дневной или круглосуточный стационар);
3. проведение генно-инженерной биологической терапии.

Выписка после операции возможна при:

1. удовлетворительном общем состоянии;
2. улучшении или восстановлении носового дыхания.

Согласно алгоритму ведения пациента (приложение Б), после диагностики пациент с аллергией или бронхиальной астмой направляется к аллергологу-иммунологу или пульмонологу. При отсутствии показаний к операции наблюдение и лечение осуществляются амбулаторно; при отрицательной динамике, как и при наличии показаний, показана госпитализация в специализированный стационар для ФЭРСХ с последующим продолжением наблюдения и медикаментозного лечения.

---

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Полипозный риносинусит» |
| Версия | 1-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2024 |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |
| Актуализация | По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года |
| Код в рубрикаторе | `890_1` · открыть текст КР ↗ |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Пациенты | Взрослые |

### 6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Таблица шкалы Lund–Mackay в приложении Г3 не соответствует тексту раздела 1.5: верхнечелюстная пазуха и передние клетки решётчатой кости указаны дважды, задние клетки решётчатой кости отсутствуют, остиомеатальный комплекс оценивается в 0–1–2 балла вместо 0 или 2, а строка «Общее количество баллов» (0–7–14 и 0–1–2) не соответствует сумме от 0 до 12 на сторону.
- Длительность применения назальных кортикостероидов указана по-разному: 3–6 месяцев (раздел 3.1), 6–12 месяцев (раздел 5), ежедневно, нередко в течение всей жизни (раздел 7).
- Кратность наблюдения в разделе 5 определяется индивидуально, с осмотрами каждые 3 месяца в течение первого года после операции; в разделе 7 указано постоянное наблюдение не реже одного раза в 3 месяца.